

NS 22231567731 | 520

MARIA DE FATIMA FARIA CARNEIRO

IDADE: 65 anos PESO: 65 ALTURA: 1.57 PROFISSÃO:
 SINTOMAS: fadiga mm / Fibromialgia / Tornozelo edema-
 QUEIXAS: Renda - cansada ao seg. ciado.
 MEDICAMENTOS: Zopiclone 5mg / Permital 50mg /
 Memória ruim / Ocetálix 5mg
 MÉDICO: Dr.º Ricardo Cavalcante / Dr.º Ana Cláudia
 EXERCÍCIO FÍSICO:

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO ☒ SIM () NÃO ~~varia~~ DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUALBEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃOFUMO () SIM ☒ NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 20 anos (2 cartelas)
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim BANHEIRO: OX Dia

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 32

OVERLAP: nega MALLAMPATI: I IAH: 7.1 SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA não

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA Arritmia

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (X) OUTROS DPOC

11/03/22 - Peruas inquietas

- usar aparelho intra-oral.

Locação { P = 4-10

S10 + N30 } automático

29/06/23 P = 6.8 fixa pressão

IAH = 0.9 (IA = 0.4 / IH = 0.1 / IC = 0.4).

05/07 23 Fez o biológico IDO = 50 / ev

25/07 23 P = 7.4 cm H₂O

IAH = 1.9 e / ev

m. de uso: 7h43'

fua.

22/08 23 P = 5.6 cm H₂O

IAH = 2.9 e / ev

Fuga = 22.4

fua.

28/11 23 P = 5.6 cm H₂O

m. de uso: 7h41'

IAH = 0.6.

abre a boca

fua

30/01 24 P = 5.6 cm H₂O

IAH = 1.0

m. de uso: 7h48'

Fuga = 8.4 l/min.

fua.

22/03
24 $P = 5.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0.4$
m. de uso: ~~6.6 lpm~~ 7h43'
fuga: 6.6 lpm.

Bem adaptada

27/05
24 $P = 5.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0.6 \text{ e/lv}$
m. de uso: 8h16'
Fuga = 11 lpm.

boa

07/10
24 $P = 5.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0.7 \text{ e/lv}$
m. de uso: 7h46'

Bem adaptado, relata
estar roubando muito
fuga

18/12
24 $P = 5.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 1.2 \text{ e/lv}$
m. de uso: 7h33'
Bem adaptado,

ficou qd, si usar.

boa

19/02
25 $P = 5.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0.4 \text{ e/lv}$
m. de uso: 7h
Fuga = 6.9 lpm.

relata que está dormindo bem

boa.

14/05/25 $P = 5.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0.6 \text{ e/lv}$
m. de uso: 8h01
fuga: 13 l/min

queixa despertando q fuga av

horo baixo (M)
horo filtro

sema

Nome: MARIA DE FATIMA FARIA CARNEIRO

Data de Nascimento: 7-7-1957

IMC: 27,18

Sexo: Feminino

Data do exame: 28-03-2023

Peso: 67 kg

Altura: 1,57 m

Médico: DRA. FERNANDA FRIGI VANTINE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 28-03-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 529,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 64,0 e 151,5 minutos. O tempo total de sono foi de 427,0 min, eficiência de 80,6% (normal $\geq 85\%$) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 56,8%; estágio N3: 17,1%; sono REM: 23,5%. O índice de despertares foi de 5,2/hora (normal $\leq 10/h$).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 3,2/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 21 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 81%, permanecendo 45,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 54 bpm e NREM de 45 - 60 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 3,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=81%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (16,6/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando roncopia primária associado a distúrbio de movimento.

Presença de bruxismo ou apertamento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARIA DE FATIMA FARIA CARNEIRO
Data de Nascimento: 7-7-1957
IMC: 25,00
Sexo: Feminino
Data do exame: 11-08-2022

Peso: 64 kg
Altura: 1,60 m
Médico: DR. RICARDO RODRIGUES
CAVALCANTE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 612,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 167,5 e 145,5 minutos. O tempo total de sono foi de 412,5, eficiência de 67,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 56,4%; estágio N3: 19,4%; sono REM: 22,3%. O índice de despertares foi de 5,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 7,1/hora, sendo elas 5 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e mínima de 82%, permanecendo 55,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 74 bpm e NREM de 53 - 75 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 7,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

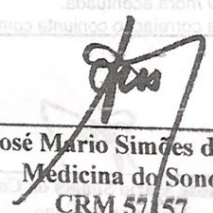
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau leve.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157